

ICLS救急時計 かんたん操作マニュアル（ブラウザ版）

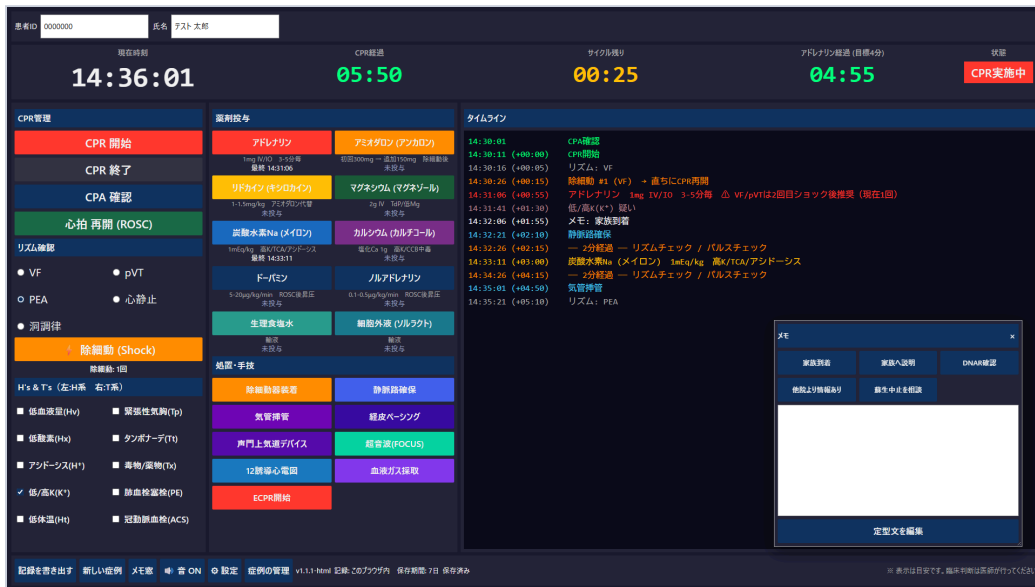
ICLS救急時計 ブラウザ版 v1.1.1-html（2026-10-09 版）

記録係として動くために必要なことを、この1冊にまとめました。設定の変えかたは載せていません。別冊の「設定ガイド」を見てください。

※ 色で意味を区別している箇所があります。カラーで印刷してください。

画面の見かた

デスクトップの「ICLS救急時計」のアイコンをダブルクリックすると、ブラウザの専用の窓が開いて、この画面が出ます。



左に操作ボタン、中央に薬剤と処置、右にタイムライン（やったことが下に流れます）。右下には小さなメモ窓が出ています。

- 使うブラウザは Microsoft Edge です
- 開いたら、画面のどこかを一度クリックします。音声は鳴るようになります。上に「音声を有効にするには...」と出ている間は鳴りません
- 画面を広く使うときは F11（全画面）を押します。もう一度押すと戻ります

① 最初に押す：CPR開始

心停止を認識したら、真っ先に「CPR開始」（左上の赤いボタン）を押します。これが全部の基準時刻になります。患者IDと氏名は、あとで入れます。空欄のままで始められます。

CPR開始とCPR終了は、セットで使います

押すボタン	いつ押すか	押すとどうなるか
CPR開始	CPRを始めたとき	時計が動き出します。2分ごとの合図も始まります
CPR終了	CPRをやめたとき（中止・終了）	時計が止まります。記録に総時間が残ります。アドレナリンの表示は灰色で止まり、音声も流れなくなります
心拍 再開 (ROSC)	心拍が戻ったとき	ROSCがCPR終了を兼ねます。ROSCを押したときは、「CPR終了」は要りません

- CPRをやめたら、必ず「CPR終了」を押します（心拍が戻ったときは「ROSC」）。押し忘れると、時計が動き続け、2分ごとの音声も流れ続けます
- 「CPR開始」の前に「CPR終了」を押しても、何も起きません。画面にも何も出ません
- 「CPR開始」を2回押すと、「CPRはすでに実施中です」と出るだけです。記録は増えません
- いったんやめて再開するときは、もう一度「CPR開始」を押します。CPR経過は0:00から数え直します

② あとは「やったこと」のボタンを押すだけ

やったこと	どこを押すか
心電図の波形を見た	「リズム確認」の VF / pVT / PEA / 心静止 / 洞調律
電気ショックをかけた	「  除細動 (Shock)」
薬や輸液を入れた	「薬剤投与」の、その薬・輸液のボタン
処置をした（挿管・静脈路確保など）	「処置・手技」の、その処置のボタン
原因を疑った／除外した	「H's & T's」のチェックを入れる・外す
家族の到着など、書き残したいことがある	右下の「メモ」窓
心拍が戻った	「心拍 再開 (ROSC)」

押した瞬間の時刻で、自動的に記録されます。あとから書く必要はありません。迷ったら、まず押して大丈夫です。押し間違えても、あとで取り消せます。

③ 4つの時計と色の意味

現在時刻

14:36:02

CPR経過

05:51

サイクル残り

00:24

アドレナリン経過 (目標4分)

04:56

状態

CPR実施中

時計	表すもの
現在時刻	いまの時刻（秒まで）
CPR経過	CPR開始からの経過時間
サイクル残り	次のリズムチェックまでの残り時間（2分ごと）
アドレナリン経過	前回のアドレナリンからの経過時間。目標は初期設定で4分

アドレナリンは「緑のうちにに入れる」（目標が4分のとき）

色	経過時間	意味
橙	3:59まで	まだ早い。待つ
緑	4:00～5:00	いま入れる
赤	5:01から	遅れている。急ぐ

サイクル残りは「赤になったら手を止める準備」

色	残り時間	意味
緑	30秒を超える	まだ余裕がある
黄	30秒以下	そろそろ交代の準備
赤	15秒以下	まもなくリズムチェック

この2つは、色の意味が逆向きです。アドレナリンは緑が「いま」、サイクル残りは赤が「もうすぐ」。

声（合成音声。ピープ音ではありません）が、2回流れます。

- 2分ごと ... 「リズムチェック」。圧迫者を交代する合図です
- アドレナリンが目標の時間になったとき ... 「じかん、です」。1回だけ流れます

CPRが終わったあと、心拍が戻ったあとは、アドレナリンの表示が灰色で止まり、音声も流れません。

④ 押し間違えたとき

記録の行を右クリックして、「この記録を取り消す」を選びます。右クリックを使わないときは、行にカーソルを合わせると出る「この記録を取り消す」ボタンを押します。カーソルのない端末（タブレットなど）では、このボタンが最初から出ています。

14:30:01	CPA確認
14:30:11 (+00:00)	CPA開始
14:30:16 (+00:05)	リズム: VF
14:30:26 (+00:15)	除細動 #1 (VF) → 直ちにCPR再開
14:31:06 (+00:55)	アドレナリン 1mg IV/IO 3-5分毎 △ VF/pvrtは2回目ショック後推奨（現在1回）
14:31:41 (+01:30)	低/高K(K ⁺) 疑い
14:32:06 (+01:55)	メモ: 家族到着
14:32:21 (+02:10)	静脈路確保
14:32:26 (+02:15)	— 2分経過 — リズムチェック / パルスチェック
14:33:11 (+03:00)	炭酸水素Na (メイロン) 1mEq/kg 高K/TCA/アシドーシス
14:34:26 (+04:15)	— 2分経過 — リズムチェック / パルスチェック
14:35:01 (+04:50)	気管挿管 この記録を取り消す
14:35:21 (+05:10)	リズム: PEA
14:36:11 (+06:00)	血液ガス採取

- 取り消した行は消えず、**打消線**が付いて残ります。あとから見返せます
- カルテに貼るときは、取り消した行は自動で除かれます
- 間違えて取り消したときは、同じ行の「取消を戻す」で戻せます
- アドレナリンを取り消すと、その前の投与が基準に戻ります。取り消した投与は「前回の投与」に数えません

⑤ メモの使いかた

メモ

家族到着

家族へ説明

DNAR確認

他院より情報あり

蘇生中止を相談

定型文を編集

- 定型文のボタン ... 押すだけで記録されます。確認は出ません（定型文を変えるときは、設定ガイドを見ます）
- 自由に書く ... 下の欄に打って **Enter** を押すと記録されます。改行は **Shift + Enter**
- 日本語を変換しているときの **Enter** は、変換の確定です。**確定してから、もう一度 Enter を押すと記録されます**

メモは、薬や処置と同じ時系列に並びます。カルテに貼ると、経過とメモが1本の記録になります。

メモ窓は、上の青い帯をドラッグして動かせます。右上の × で閉じても、下部の「メモ窓」ボタンで開き直せます。画面が小さいとき（ブラウザを拡大表示しているときなど）は、最初は閉じています。

⑥ 記録を終えて、カルテに貼るまで

記録の書き出し

☒ 取り消した記録を除く

☐ 経過記録（1行形式）

☐ サマリ（見出し＋本文）

【心肺蘇生 経過記録】

患者ID: 0000000 氏名: テスト 太郎

CPA確認 14:30:01 / CPR開始 14:30:11

除細動 1回 アドレナリン 1回

14:30:01 CPA確認

14:30:11 (+00:00) CPR開始

14:30:16 (+00:05) リズム: VF

14:30:26 (+00:15) 除細動 #1 (VF) → 直ちにCPR再開

14:31:06 (+00:55) アドレナリン 1mg IV/IO 3-5分毎 △ VF/pVTは2回目ショック後推奨（現在1回）

14:31:41 (+01:30) 低/高K(K⁺) 疑い

14:32:06 (+01:55) メモ: 家族到着

14:32:21 (+02:10) 静脈路確保

14:32:26 (+02:15) — 2分経過 — リズムチェック / パルスチェック

14:33:11 (+03:00) 炭酸水素Na (メイロン) 1mEq/kg 高K/TCA/アシドーシス

14:34:26 (+04:15) — 2分経過 — リズムチェック / パルスチェック

14:35:01 (+04:50) 気管挿管

14:35:21 (+05:10) リズム: PEA

(救急時計 v1.1.1-html で記録)

クリップボードにコピー

CSVで保存

- 落ち着いたら、上の欄に**患者ID・氏名**を入れます（あとから入れても、それ以前の記録すべてに付きます）
- 下部の「**記録を書き出す**」を押します
- 形式を選びます
 - 経過記録** ... カルテの経過欄に貼れる、1行ずつの形式
 - サマリ** ... 冒頭にCPR時間や除細動の回数などの要点、その下に経過が続く形式
- プレビューは書き直せます。コピーされるのは、書き直したあとの内容です
- 「**クリップボードにコピー**」を押して、カルテに貼り付けます
- 表計算ソフトで使うときは「**CSVで保存**」を押します（保存先を選ぶ画面が出ます）

⑦ 次の患者さんが来たら

カルテへの貼り付けが終わってから、「新しい症例」を押します。画面が新しくなります。前の患者さんの記録は、このパソコンのブラウザの中に残っています（⑨）。

⑧ 画面を閉じてしまった・パソコンが止まったとき

もう一度開くと、「前回の記録が残っています。続きから開きますか？」と出ます。「はい」を押すと、記録も時計も元どおりになります。CPR中に画面を閉じたり更新したりしようとすると、確認が出ます。「キャンセル」を押せば、そのまま続けられます。

⑨ 記録の置き場所と、消えるとき

- 記録は、いま使っているパソコンの、このブラウザの中に保存されます。画面下に「記録: このブラウザ内」と出ています
- 別のパソコンや、別のブラウザ（EdgeとChromeなど）からは見えません
- 保存期間（初期値7日）を過ぎた記録は、次に開いたときに自動で消えます
- 下部の「症例の管理」で、残っている記録を見られます。控えを書き出す（JSONLで保存）、1件を消す（削除）、全部消す（すべて削除）もここです。削除は**元に戻せません**

症例の管理

10/09 14:29 開始・記録14件（現在）

JSONLで保存

削除

すべて削除

- 共用のパソコンでは、使い終わった症例を「**削除**」します。次に使う人に、患者さんの情報が見えてしまいます
- ブラウザの「**閲覧データの削除**」でサイトデータを消すと、記録も一緒に消えます

困ったとき

こうなった	こうする
CPRをやめたのに、時計が動き続けて、2分ごとの音声も流れる	「CPR終了」（心拍が戻ったときは「ROSC」）の押し忘れです。いま押せば止まります。押した時刻が終了の時刻になります
音声が届かない	画面のどこかを一度クリックします。それでも鳴らなければ、責任者に伝えます（声の選びかたは設定ガイド）
上に「日本語の音声が見つかりません」と出た	音声の代わりに、ビープ音が鳴ります（2分ごとは短く2回、アドレナリンは短く3回）。そのまま使えます
音を止めたい	下部の「  音」を押して、OFFにします
メモ窓が消えた	下部の「メモ窓」を押します
「すでに別のタブで開いています」と出た	すでに開いている救急時計の画面を使います。見つからないときは、ブラウザをすべて閉じて、開き直します
上に赤く「記録を保存できません」と出た	この画面を閉じると、記録が失われます。 「記録を書き出す」でコピーして控えを取り、責任者に伝えます。プライベートウィンドウ（InPrivate・シークレット）で開いていないかも確かめます
患者IDを入れ忘れた	「記録を書き出す」を押す前なら、いつでも入れられます
定型文を変えたい	責任者に相談します（設定ガイド）

やってはいけないこと

- 複数人で同時に押す ... 記録が二重になります。記録係は1人にします
- 貼り付ける前に「新しい症例」を押す ... 画面の表示が消えます（記録は「症例の管理」に残りますが、手間が増えます）
- プライベートウィンドウ（InPrivate・シークレット）で使う ... 閉じると、記録が消えます
- EdgeとChromeを両方開いて、それぞれで使う ... 記録が別々になり、二重の起動も防げません。使うブラウザは1つに決めます
- 終わった症例を、共用パソコンに残す ... ⑨のとおり、削除します

※ 表示される用量とタイミングは目安です。臨床判断は、必ず医師が行います。※ 記録の正本は診療録です。このツールの出力は、補助資料として扱います。

用語集（裏面）

略語

略語	読み	意味
CPA	シーピーイー	心肺停止。心臓も呼吸も止まっている状態
CPR	シーピーアール	心肺蘇生。胸骨圧迫と人工呼吸
ROSC	ロスク	自己心拍再開。蘇生がいったん成功した状態
VF	ブイエフ	心室細動。電気ショックが効く波形
pVT	ピーブイティー	無脈性心室頻拍。これも電気ショックが効く波形
PEA	ピーイーイー	無脈性電気活動。波形はあるのに脈が触れない。ショックは効かない
心静止	asystole	心電図が平坦な状態。ショックは効かない
除細動	じょさいどう	電気ショックのこと。VF・pVTのときだけ行う

H's & T's（見つけて治せる原因）

心停止には、見つけて治せる原因が10個あります。頭文字がHとTなので、こう呼ばれます。疑わしいものにチェックを入れると「疑い」、外すと「除外」として記録されます。

H系（左側）	内容	T系（右側）	内容
低血液量(Hv)	出血や脱水で、血が足りない	緊張性気胸(Tp)	肺から空気が漏れて、圧迫している
低酸素(Hx)	酸素が足りない	タンポナーデ(Tt)	心臓の周りに、水や血が溜まっている
アシドーシス(H ⁺)	体が酸性に傾いている	毒物/薬物(Tx)	薬や毒物による中毒
低/高K(K ⁺)	血液中のカリウムの異常	肺血栓塞栓(PE)	肺の血管が、血の塊で詰まっている
低体温(Ht)	体温が下がりすぎている	冠動脈血栓(ACS)	心臓の血管が詰まっている（心筋梗塞）

ボタンの並び

薬剤投与（10個） ... アドレナリン／アミオダロン（アンカロン）／リドカイン（キシロカイン）／マグネシウム（マグネゾール）／炭酸水素Na（メイロン）／カルシウム（カルチコール）／ドーパミン／ノルアドレナリン／生理食塩水／細胞外液（ソララクト）

処置・手技（9個） ... 除細動器装着／静脈路確保／気管挿管／経皮ペースング／声門上気道デバイス／超音波(FOCUS)／12誘導心電図／血液ガス採取／ECPR開始

薬剤のボタンの下に、用量の目安が小さく書いてあります。投与量の計算はしません。表示は目安です。

個人情報の取り扱い

このアプリは、患者ID・氏名を記録します。記録は、このパソコンのブラウザの中に保存され、インターネットには送られません（外部との通信はしません）。

- 記録の正本は診療録です。アプリの記録は補助資料として扱います
- 保存期間（初期値7日）を過ぎた記録は、自動で消えます。共用のパソコンでは、終わった症例を「症例の管理」から削除します
- 「JSONLで保存」「CSVで保存」で作ったファイルにも、患者さんの情報が入っています。ダウンロードしたフォルダに置いたままにせず、決められた場所で扱い、不要になったら削除します
- 端末の運用ルールに従います。保存期間や削除の判断は、所属部署の取り決めに合わせます

困ったこと、分からないことがあれば、一人で悩まず、上司やシステム責任者に確認してください。